BVĐK NHẬT TÂN
Phòng Điều Dưỡng
Số: 01/QyĐ-PĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Đốc, ngày 03 tháng 8 năm 2020

QUY ĐỊNH

CÁCH TRÌNH BÀY QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG

A. CẤU TRÚC MỘT QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG

Tùy theo cấu trúc của mỗi quy trình, mỗi quy trình phải có các phần chủ yếu sau đây:

NHẬN ĐỊNH

Thu thập mọi thông tin về người bệnh. Cần tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, nếu cần có thể tiếp xúc với gia đình người bệnh.

1. NHẬN ĐỊNH NGƯỜI BỆNH LÀ MỘT QUY TRÌNH GỒM

Khai thác tiền sử.

Các kết quả khám thực thể.

Ghi nhận các dấu hiệu sinh tồn, cân nặng.

Hồ sơ điều trị.

Các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng của người bệnh.

2. NHỮNG DỮ LIỆU CHỦ QUAN HOẶC KHÁCH QUAN

Dữ liệu chủ quan do người bệnh thông báo.

Dữ liệu khách quan do người điều dưỡng xem xét, nhận định qua sự quan sát tiếp xúc người bệnh.

2.1. Khai thác tiền sử

Phỏng vấn người bệnh hoặc thân nhân trong gia đình.

Nên dùng câu hỏi mở để người bệnh cung cấp thông tin đầy đủ hơn.

Hướng dẫn người bệnh khai những thông tin có giá trị và liên quan đến bệnh của họ.

Các yêu cầu trong tiền sử:

- Xác định được bệnh hoặc có liên quan đến sức khỏe.
- Nêu lên được diễn tiến của bệnh.
- Nêu được tiền sử cá nhân người bệnh, gia đình người bệnh và các quan hệ xã hội nếu có.

Xác nhận vấn đề sức khỏe, nên dùng các câu hỏi có nội dung như sau:

- Khi đau lúc nào?

- Thời gian bao lâu?
- Vị trí nơi bệnh?
- Mức độ nghiêm trọng: số lượng, tính chất các triệu chứng?
- Yếu tố làm tăng giảm triệu chứng?
- Đã điều trị nội? Ngoại khoa trước đây?

2.2. Khám các hệ thống của cơ thể

2.2.1. Chuẩn bị người bệnh trước khi khám:

Giải thích cho họ biết.

Giúp người bệnh trước khi khám.

Đảm bảo họ được thoải mái.

Che kín các nơi khi bỏ quần áo họ ra bằng drap (vải trải) đắp.

Luôn giải thích cho họ hiểu điều mình sẽ làm trong quá trình khám cho người bệnh.

Sắp xếp dụng cụ thuận tiện.

2.2.2. Các kỹ thuật thăm khám:

Quan sát người bệnh: tổng thể tình trạng người bệnh, tri thức người bệnh, các biến chứng lâm sàng nơi người bệnh.

Khi quan sát cần bao quát và kết hợp lúc khám, cần khách quan và không nên đoán.

Đánh giá bằng sự thăm khám:

- Bằng những dụng cụ khám thực thể.
- Ống nghe: nghe tiếng tim, nghe phổi.
- Máy đo huyết áp: cần sử dụng cùng với ống nghe.
- Đèn soi, ống soi để khám bên trong các xoang.
- Dùng các ngũ quan để khám.

Ví dụ:

- Nhìn: biết được tổng quát tình trạng người bệnh, nhìn các dấu hiệu bất thường trên da, niêm mạc, tình trạng vệ sinh, các vấn đề khó khăn của người bệnh.
- Nghe: nghe tiếng tim, tiếng phổi.
- Sờ: cảm giác nhiệt độ ở da. Sự đàn hồi của da – các mức độ cứng, mềm ở các vị trí.
- Ngửi: mùi vi sinh vật trong nước tiểu, trong phân và các dịch tiết khác hoặc mùi hơi thở.

Ghi chép cẩn thận khi phát hiện các vấn đề bất thường.

Ghi vào phiếu theo dõi và chăm sóc. Khi ghi chép nên tận dụng kỹ năng.

Người điều dưỡng phải tận dụng kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng nghe.
- Kỹ năng ra quyết định (xem vấn đề nào cần xử trí trước, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên trong quy trình):
  - Ảnh hưởng đến tính mạng.
  - Làm bệnh nhân thấy bất an.
  - Những việc có thể kéo dài.

2.2.3. Yêu cầu:

- Phải có tính tổng quát, bao gồm nhiều điểm khác nhau.
- Phải khách quan.
- Được cập nhật hóa thường xuyên, ghi chép chính xác.

3. CHẨN ĐOÁN ĐIỀU DƯỠNG

Từ nguồn thu thập dữ kiện, người điều dưỡng phải thiết lập các chẩn đoán điều dưỡng. Đây là sự đánh giá về tình trạng sức khỏe của người bệnh hay là kết quả của việc nhận định đánh giá của điều dưỡng dựa trên các phần thu thập dữ kiện. Người điều dưỡng dựa vào chẩn đoán điều dưỡng để xây dựng hướng can thiệp điều dưỡng và thành lập nên kế hoạch chăm sóc.

Là những kế hoạch cần làm để giải quyết những nhu cầu của bệnh nhân mà điều dưỡng nhận định.

Phải làm từ đơn giản trước (có hiệu quả) sau đó mới làm đến phức tạp (nếu làm đơn giản không hiệu quả).

3.1. Yêu cầu về chẩn đoán điều dưỡng

Là một cụm từ nêu lên vấn đề của người bệnh cần điều dưỡng đáp ứng.

Khi nêu chẩn đoán điều dưỡng cần lưu ý:

- Ngắn gọn, rõ ràng.
- Chính xác dựa trên dữ kiện có thật.

Gồm 2 vế: Vấn đề của bệnh nhân + nguyên nhân (nếu biết).

3.2. Phân biệt chẩn đoán điều dưỡng và chẩn đoán điều trị

Chẩn đoán điều trị	Chẩn đoán điều dưỡng
Mô tả bệnh	Mô tả phản ứng của con người
Tồn tại trong quá trình bệnh	Thay đổi trong quá trình theo đáp ứng của con người

LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC

Các kế hoạch lập ra nên đi từ các việc chăm sóc đơn giản đến phức tạp, những dự trù trên bệnh nhân để đạt được kế hoạch chăm sóc.

1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHĂM SÓC

Xác định ưu tiên: những vấn đề nào ảnh hưởng đến khả năng sống còn của bệnh nhân thì đưa lên trên, hoặc nếu không thực hiện thì để lại di chứng cho người bệnh. Xác định ưu tiên dựa vào 14 nhu cầu cơ bản.

Xác định vấn đề trước mắt: những vấn đề xảy ra trong hiện tại, trong thời gian ngắn và cần có sự can thiệp ngay.

Xác định vấn đề lâu dài: những vấn đề có thể xảy ra trong hiện tại và kéo dài, hoặc những vấn đề có thể xảy ra biến chứng.

2. MỤC TIÊU CHĂM SÓC

Mục tiêu đặt ra để có hướng đạt được khi giải quyết vấn đề của bệnh nhân.

Mục tiêu mà người bệnh cần đạt.

Nên viết ngắn gọn, từ ngữ rõ ràng và có tiêu chuẩn để đạt được thì càng tốt.

Phải gắn với chẩn đoán điều dưỡng.

Nếu có thể nên ấn định thời gian đạt được mục tiêu thì càng cụ thể hơn.

Kết quả liên quan đến bệnh nhân, không phải là hành động của điều dưỡng.

THỰC HIỆN CHĂM SÓC

Các kế hoạch nên có khả năng thực thi.

Kế hoạch trước mắt theo các vấn đề ưu tiên đã đạt được xác định.

Kế hoạch giải quyết các vấn đề trước mắt làm ngay.

Kế hoạch ưu tiên cũng phải đề ra.

Việc phải làm từ kế hoạch đặt ra, làm đến khi nào có kết quả chứ không làm hết kế hoạch.

Giáo dục sức khỏe.

ĐÁNH GIÁ

Có tiêu chuẩn đánh giá từng vấn đề (dựa vào mục tiêu), không được nói chung chung và dựa vào hỏi bệnh nhân.

Đánh giá xem việc chăm sóc ở mức độ nào để kết thúc công việc, hoặc bổ sung hoặc thay đổi.

Phải đánh giá kết quả, ghi tình trạng hiện tại, các số liệu.

Lượng giá trong khi thực hiện, sau khi thực hiện và tái thẩm định lại.

Chú ý: khi nhận định thăm khám bệnh nhân và đánh giá sau khi chăm sóc thì phải ghi rõ số liệu tình trạng bệnh nhân để so sánh và đánh giá việc thực hiện cho bệnh nhân. ví dụ: sốt bao nhiêu độ.

Yêu cầu của phiếu ghi chăm sóc:

Phải sử dụng từ chung nhất (đọc lên hiểu được), dễ hiểu.

Phải cụ thể.

Phải thực tế.

Phải được nhiều người tham gia kể cả bệnh nhân.

B. HÌNH THỨC CHUNG

Số trang: Tối đa 6 trang, trừ trường hợp đặc biệt

Kiểu chữ: Times New Roman

Cỡ chữ: 12

Riêng đầu đề: CHỮ IN, THẲNG, ĐẬM, CANH GIỮA, CỠ CHỮ 16

CÁC ĐỀ MỤC

Các đề mục 1 (heading 1): KHÔNG ĐÁNH SỐ, CHỮ IN, THẲNG, ĐẬM, CỠ CHỮ 12

Các đề mục 2: *ĐÁNH SỐ, CHỮ IN, NGHIÊNG, ĐẬM, CỠ CHỮ 12*

Các đề mục 3: Đánh số, chữ thường, nghiêng, đậm, cỡ chữ 12.

***Các đề mục 4*: Đánh số, chữ thường, không đậm, cỡ chữ 12.**

KHOẢNG CÁCH CÁC DÒNG

- Thông thường: before 6 pt, after 0 pt, line spacing: single
- Từ đầu đề đến dòng thứ nhất cách nhau 12 pt.

TRÌNH BÀY TRANG (PAGE LAYOUT)

Margin: Top 1 inch, Bottom 1 inch, Left 1.4 inch, Right 0.7 inch. Orientation: Portrait, đôi khi có bảng biểu thì cần đến Landscape. Multiple Pages: Normal. Khi đóng thành sách chọn định dạng: Mirror margins.

KHI DÙNG BULLETS

- Bullet 1: Không cần phải thụt vào.
  - Bullet 2: Phải thụt vào khoảng 0,1''.

Mỗi bullet không cần phải cách khoảng: Spacing: Before 0, After 0. Line spacing: Single.

ĐÁNH SỐ TRANG VÀ CHỈNH HÀNG

- Sau khi xong thì đánh số trang ở phía dưới bên phải.
- Chỉnh hàng cho đều nhau (align).

Giám đốc

M.S.D.N: 1600589438 - C.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN DA KHOA NHẬT TÂN
T.P CHÂU ĐỐC - AN GIANG

Ts.Bs Châu Hữu Hầu

TP. Điều dưỡng

Võ Hồng Thái